Uso de Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) para la Enfermedad de Chagas. Experiencia en Salta

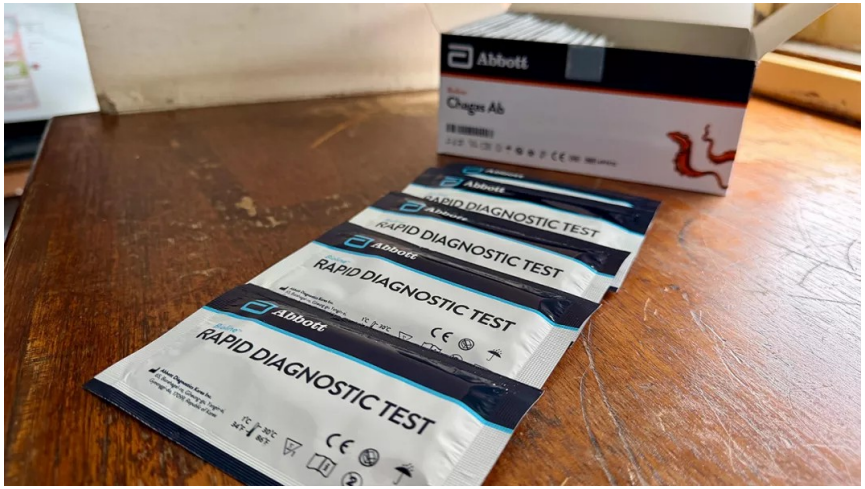
Ministerio de Salud Pública | SALTA GOBIERNO

Secretaría General Iberoamericana
Secretaria-Geral Ibero-Americana

NINGÚN BEBÉ CON CHAGAS
Iniciativa Iberoamericana

JORNADAS DE SALUD TERRITORIAL: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ETMI PLUS Y ATENCIÓN EQUITATIVA

Mg. SP Francisco García Campos



DGCE - MSP - SALTA

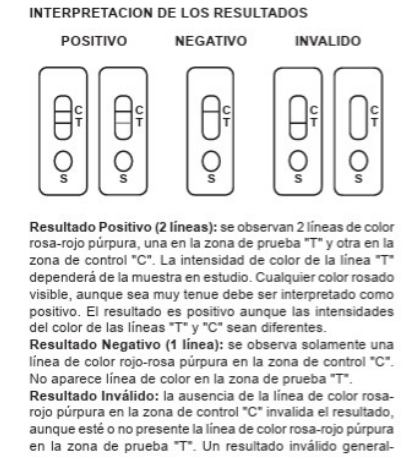
© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

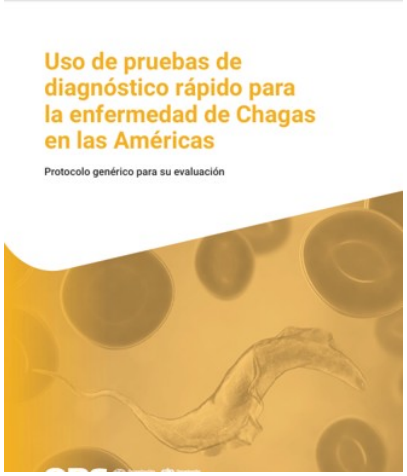
Que es una PDR para el diagnóstico de Chagas

Es un método indirecto (inmunológico o serológico) diseñado principalmente para la etapa crónica de la infección.

Su función es detectar anticuerpos específicos de clase inmunoglobulina G (IgG) dirigidos contra el parásito *Trypanosoma cruzi* en muestras clínicas.

Estas pruebas funcionan bajo el principio de **inmunocromatografía de flujo lateral** y utilizan diversos tipos de antígenos del parásito —ya sean lisados totales, purificados, proteínas recombinantes o sintéticas— para capturar los anticuerpos del paciente y generar una banda coloreada visible si el resultado es reactivo.





© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Escenarios de uso de las pruebas rápidas



La introducción de PDR para la detección de anticuerpos específicos contra antígenos de T. cruzi mediante inmunocromatografía forma parte de las metodologías disponibles para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica.



Con base en la revisión de la literatura publicada y la opinión de expertos recabada para este protocolo, se presentan los escenarios en los cuales una prueba que ha sido estandarizada, validada y/o verificada podría ser empleada en estudios con sujetos o muestras sin resultado conocidos.



En caso de obtenerse resultados positivos, se deberá realizar una segunda prueba confirmatoria, conforme a las recomendaciones de la OPS.



Esta incorporación ha generado la necesidad de evaluar su desempeño y determinar en qué situaciones podrían emplearse estos reactivos de manera efectiva.



Se destacan las ventajas del uso de PDR como herramienta inicial de detección de anticuerpos específicos para *T. cruzi*.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Escenarios recomendados

Estudio de campo

a. Búsqueda activa en poblaciones expuestas.

b. Estudio de contactos de casos positivos confirmados.

c. Estudio de prevalencia e incidencia con fines de salud pública.

Zonas de difícil acceso

Rondas de equipos de salud a poblaciones remotas o aisladas.

Evaluación de la inclusión de PDR en algoritmos de diagnóstico

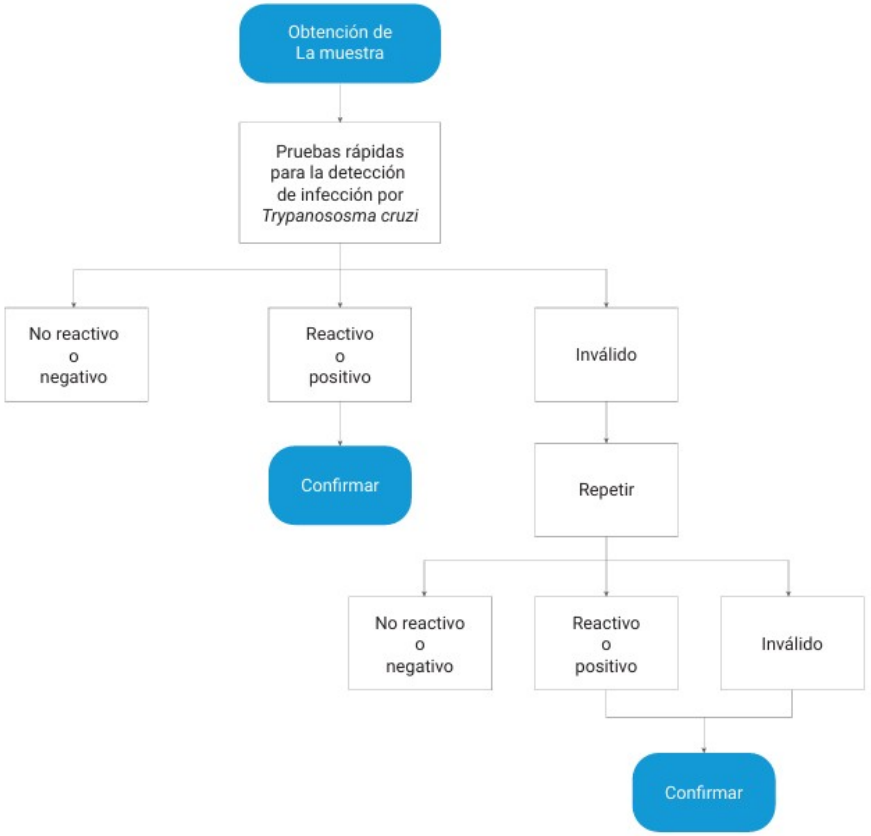
d. Estudios que incluyan muestras con resultados positivos y negativos conocidos en el contexto de una propuesta de modificación o formulación de un algoritmo.

e. Estudios comparativos de diferentes alternativas de PDR disponibles en el mercado.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Algoritmo para la evaluación de pruebas rápidas de infección por *Trypanosoma cruzi*

DGCE - MSP - SALTA



© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Ampliar cobertura y descentralizar el diagnóstico

El Desafío Crónico

En la etapa crónica, la detección de inmunoglobulinas específicas (IgG) mediante métodos indirectos es el estándar de oro, pero el acceso está severamente limitado en áreas rurales dispersas debido a la complejidad de los laboratorios convencionales.

Las PDR como Solución

Las **Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR)** basadas en inmunocromatografía de flujo lateral ofrecen ventajas críticas: almacenamiento a temperatura ambiente, lectura en 15-30 minutos, simplicidad operativa y uso de muestras de sangre entera.

Prioridad Sanitaria

Su implementación es una herramienta fundamental en estrategias de eliminación facilitando el tamizaje universal de diferentes poblaciones.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Criterios de Selección y la Obligatoriedad de "Verificación Local"

Estándares de Aceptación de la OPS

Para que una PDR sea seleccionada para su implementación, el protocolo de la OPS exige un umbral de desempeño riguroso: **sensibilidad superior al 92%** y **especificidad superior al 95%**.

El Requisito de Verificación (Un Paso Crítico)

La OPS enfatiza que los datos de validación de los fabricantes suelen obtenerse en entornos controlados y con paneles de sueros homogéneos. Por ello, establece como **obligatoria la verificación local del método** en el territorio antes de su uso clínico regular.

¿Por qué verificar en terreno?

El rendimiento de las PDR varía geográficamente debido a:

- La diversidad de cepas de *T. cruzi*
- Las diferencias genéticas en la respuesta inmunológica de las poblaciones locales.
- Las características del entorno de operación en el primer nivel de atención.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

DGCE - MSP - SALTA

De la Evidencia de Laboratorio al Terreno de Salta

El Vacío de Evidencia Global (2010–2014)

Recomendación OMS (2010)

La 63ª Asamblea Mundial de la Salud recomendó la detección rápida de Chagas en el primer nivel de atención .

La Limitación:

El estudio de referencia inicial evaluó 8 pruebas rápidas (PDR) en 11 centros de referencia, pero utilizando **muestras de suero congelado de biobancos** .

La Necesidad

Era imperativo demostrar su desempeño clínico real en el terreno usando **sangre entera** y en diferentes escenarios epidemiológicos .

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

DGCE - MSP - SALTA

El Hito Piloto de Salta: Alto la Sierra (2017)

Metodología

Evaluación en la comunidad rural dispersa de **Alto la Sierra (Salta)** con 148 personas, comparando el uso de suero frente a sangre entera con EDTA usando *SD-Bioline* .

Resultados Excepcionales:

Tasa de infección detectada: 10.8%

Sensibilidad: 100% (IC 95%: 96.8% - 100%)

Especificidad: 93.9%

Conclusión clave

No se observaron diferencias en el rendimiento al usar sangre entera capilar en comparación con suero de laboratorio convencional .

El paso siguiente

Este éxito inicial impulsó el estudio definitivo (2018) para evaluar dos kits comerciales en áreas de alta endemicidad (Salta) y no endemicidad (Buenos Aires) .

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

La Experiencia de Salta (2018-2020) como Pionera de la Normativa Internacional

Evidencia Integrada

La publicación de **Lopez-Albizu, et al. (2020)** fue incorporada formalmente en la revisión de alcance que dio sustento científico al protocolo genérico de la OPS (2025), figurando como un antecedente metodológico clave para el uso de sangre entera en América Latina.

Salta ya hizo la tarea

Mientras que el protocolo de la OPS (2025) instruye a los países sobre *cómo* diseñar y ejecutar estudios de verificación, **la provincia de Salta ya ejecutó esta validación en terreno en 2018**.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY | Journal of Clinical Microbiology®

PARASITOLOGY

Rapid Diagnostic Tests for *Trypanosoma cruzi* Infection: Field Evaluation of Two Registered Kits in a Region of Endemicity and a Region of Nonendemicity in Argentina

Constanza Lopez-Albizu,[a,c] Emmaría Danesi,[b,c] Pablo Piorno,[c] Mariana Fernandez,[c] Francisco García Campos,[d] Karenina Scollo,[a] Favio Crudo[c]

[a]Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbran, Buenos Aires, Argentina

[b]Centro Nacional de Investigación y Diagnóstico de Endemo-epidemias, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos G. Malbran, Buenos Aires, Argentina

[c]Asociación para Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), Buenos Aires, Argentina

[d]Ministerio de Salud Pública de Salta, Salta, Argentina

Constanza Lopez-Albizu and Emmaría Danesi contributed equally to this work. Author order was determined in order of the contribution made by each institution to the project.

ACKNOWLEDGMENTS

We thank the collaboration of the professionals from the participating laboratories that obtained and processed samples and gave administrative support: Daniela Oliveto, Laura Mansilla, Mariana Gosende, Marisa Pico, Oscar Fernandez, and Marcelo Gonzalez from the INP; Adrian Cardozo from San Carlos Hospital; Patricia Serrano from Cafayate Hospital; and Carolina Herrero, Manuela Bono, and María José Barbagallo from Orán Hospital. We also thank Analía Guilera, Tomás Orduna, Ignacio Di Camillo, Yanina Loiza, and Pamela Testardini from Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), who also collaborated in the field work. We also thank Soledad Santini for the valuable support for the project development, Marisa Fernandez and Maximiliano Wilda for revision of the manuscript, and María Victoria Periago for translation of the manuscript.

DGCE - MSP - SALTA

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

DGCE - MSP - SALTA

CUADRO A6.2. **Estudios individuales incluidos**

Autor principal	Año de publicación	Lugar o país de origen	Tipo de estudio	Objetivo general	Tipo de muestras	Número de muestras	Nombre de los reactivos RDT incluidos	Metodología	Análisis estadísticos
López-Albizu	2020	Argentina	Estudio de intervención prospectivo	Evaluar en campo dos pruebas diagnósticas rápidas *in vitro* para la enfermedad de Chagas en áreas de endemicidad y no endemicidad en Argentina.	Muestras de sangre completa	607	Chagas Ab Standard Diagnostics SD Bioline (SD) y Check Chagas Wiener Lab (WL)	Recolección de sangre venosa, realización de RDT *in situ*, y serología confirmatoria en un centro de referencia.	Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, índice kappa, índice de Youden, todos con sus respectivos intervalos de confianza del 95%.
Murphy	2019	Argentina	Investigación	Evaluar la eficacia de pruebas diagnósticas rápidas específicas de linaje para identificar la distribución ecológica y epidemiológica de *T. cruzi* TcII/V/VI en el Chaco Argentino.	Sueros humanos, caninos, felinos y de armadillo.	Humanos, 393; perros, 85; gatos, 19; armadillos, 7	Chagas Sero K-SeT	Ensayos serológicos específicos de linaje TSSApep en ELISA y pruebas rápidas Chagas Sero K-SeT usando péptidos sintéticos representativos de epítopos específicos de linaje del antígeno pequeño de superficie del tripomastigote (TSSA).	Pruebas ELISA específicas de linaje TSSApep-II/V/VI, -III, -IV, -V/VI, análisis de prevalencia y asociación estadística utilizando test exacto de Fisher y regresión logística multivariada.
Pinazo	2021	España	Revisión	Evaluar la efectividad de las pruebas diagnósticas rápidas para la enfermedad de Chagas.	Sangre entera obtenida por punción digital	No especificado.	SD Bioline ChagasAb, WL Check Chagas	Evaluación en campo de dos kits registrados en una región endémica y otra no endémica de Argentina.	Concordancia con serología convencional (IHA, ELISA, IIF).

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Metodología Aplicada

Población

607 voluntarios mayores de 18 años evaluados en áreas endémicas bajo control vectorial de Salta (Alto La Sierra, Cafayate, San Carlos, Orán) y un área no endémica de control (INP, Buenos Aires).

Pruebas Evaluadas

SD Bioline Chagas AB (SD) y *WL Check Chagas Wiener Lab* (WL) procesadas *in situ* con sangre entera obtenida por punción venosa.

Estándar de Referencia

Diagnóstico convencional ciego de tres pruebas (ELISA, HAI e IFI) en el centro nacional de referencia (INP).

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Desempeño en Salta vs. Criterios OPS

Resultados Globales de Sensibilidad y Especificidad (545 casos analizados)

- **SD Bioline (SD):** Sensibilidad del **97.2%** y especificidad del **97.7%**.
- **Wiener Lab (WL):** Sensibilidad del **93.4%** y especificidad del **99.1%**.

Rendimiento Específico en el Terreno (Salta)

El desempeño fue aún más alto al segmentar la población residente de la provincia:

- **SD Bioline en Salta:** Alcanzó una **sensibilidad del 98.1%** y un **Valor Predictivo Negativo (VPN) del 99.7%**. Esto significa que en territorio salteño, la probabilidad de un falso negativo utilizando este kit es de apenas el 0.3%.
- **Wiener Lab en Salta:** Logró una **especificidad del 99.6%** y una sensibilidad de 94.3%.

Cumplimiento de Umbrales

Ambos reactivos superaron holgadamente el criterio de aceptación mínimo de la OPS (Sensibilidad >92%, Especificidad >95%)

y los parámetros recomendados en sus guías de diagnóstico clínico (Sensibilidad ≥94%, Especificidad ≥97%).

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Ficha Técnica y Objetivo del Estudio

Título de la publicación

Rapid Diagnostic Tests for Trypanosoma cruzi Infection: Field Evaluation of Two Registered Kits in a Region of Endemicity and a Region of Nonendemicity in Argentina.

Autores principales

Constanza Lopez-Albizu, Emmaría Danesi, Pablo Piorno, Mariana Fernandez, Francisco García Campos, Karenina Scollo y Favio Crudo.

Objetivo general

Evaluar en el terreno el rendimiento diagnóstico de dos pruebas rápidas *in vitro* para Chagas, autorizadas por la ANMAT en Argentina, utilizando muestras de sangre entera en áreas endémicas y no endémicas.

Población evaluada

607 voluntarios mayores de 18 años sin tratamiento previo para Chagas, reclutados en 2018.

- *Área Endémica (Provincia de Salta):* Localidades de Alto La Sierra, Cafayate, San Carlos y Orán.
- *Área No Endémica:* Ciudad de Buenos Aires y alrededores (pacientes del Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben - INP).

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Metodología y Herramientas Evaluadas

Pruebas Rápidas (RDTs) Evaluadas (in situ)

- **Chagas Ab Standard Diagnostics SD Bioline (SD)**.
- **WL Check Chagas Wiener Lab (WL)**.

Muestra utilizada en territorio

Sangre entera obtenida por punción venosa (tubo con EDTA), procesada de forma inmediata directamente en el campo.

Estándar de Oro (Gold Standard)

Serología convencional (CS) realizada en el centro de referencia (INP) combinando tres pruebas:

ELISA, HAI (Hemoaglutinación Indirecta) e IFI (Inmunofluorescencia Indirecta).

Un caso se consideró verdaderamente positivo con al menos dos pruebas serológicas reactivas.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

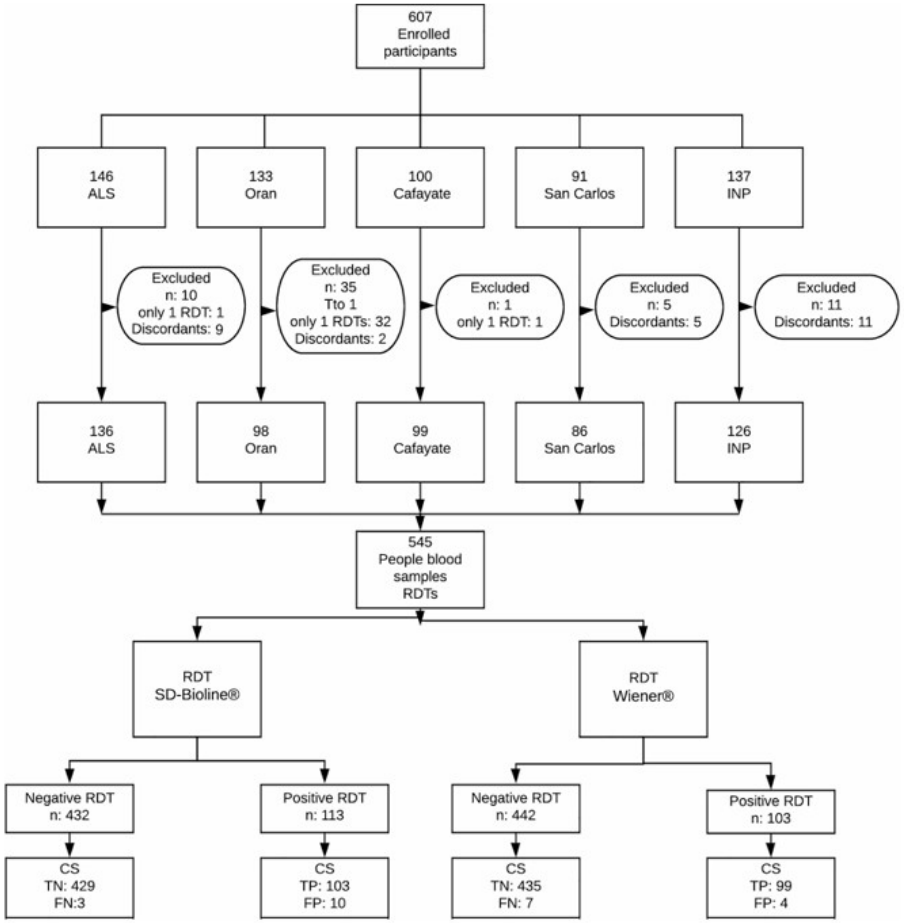


FIG 1 Recruiting algorithm of the participants. Abbreviations: ALS, Alto La Sierra; INP, National Institute of Parasitology; Tto, treatment; RDTs, rapid diagnostic tests; TP, true positive; FN, false negative; CS, conventional serology.

DGCE - MSP - SALTA

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

TABLE 2 Performance parameters of rapid diagnostic tests (RDTs) for Chagas disease[a]

	RDT SD-Bioline			RDT Wiener		
	I	NI	T	I	NI	T
P	103	10	113	99	4	103
N	3	429	432	7	435	442
T	106	439	545	106	439	545

	%	95% CI	%	95% CI
Sensitivity	97.2	93.5-100	93.4	88.2-98.6
Specificity	97.7	96.2-99.2	99.1	98.1-100
PPV	91.2	85.5-96.8	96.1	91.9-100
NPV	99.3	98.4-100	98.4	97.1-99.7
Youden Index	0.95	0.91-0.98	0.92	0.88-0.97
Kappa Index	0.93	0.89-0.97	0.93	0.90-0.97
PLR	42.7	23.1-78.8	102.5	38.6-272.2
NLR	0.03	0.01-0.09	0.07	0.03-0.14

[a]P, positive; N, negative; I, infected; NI, not infected; T, total; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; PLR, positive likelihood ratio; NLR, negative likelihood ratio.

DGCE - MSP - SALTA

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Resultados Generales de Rendimiento

La tasa global de infección confirmada en la muestra fue del **17.8%** (108 de 607 voluntarios).

Para el análisis de exactitud final, se consideraron 545 casos (excluyendo discordantes, tratamientos previos y muestras incompletas):

Rendimiento de SD Bioline (SD):

- **Sensibilidad: 97.2%** (detectó 103 de 106 infectados; solo 3 falsos negativos).
- **Especificidad: 97.7%** (10 falsos positivos de 439 sanos).
- **Valor Predictivo Negativo (VPN): 99.3%**.

- **Rendimiento de WL Check Wiener Lab (WL):**
  - **Sensibilidad: 93.4%** (7 falsos negativos).
  - **Especificidad: 99.1%** (solo 4 falsos positivos).
  - **Valor Predictivo Positivo (VPP): 96.1%**.
- **Uso en paralelo:** El uso simultáneo de ambos test **no incrementó la sensibilidad** debido a la coincidencia de las muestras que resultaron en falsos negativos.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Comportamiento en Territorio (Salta vs. Buenos Aires)

El estudio demostró que **el rendimiento de los test rápidos es mejor en áreas de alta endemicidad** (como Salta) en comparación con zonas no endémicas (Buenos Aires).

Esto se vincula a una respuesta inmunológica más robusta y mayor nivel de anticuerpos debido a infecciones o reinfecciones más recientes en territorio:

Resultados en la Provincia de Salta (Grupo Endémico):

- El test **SD Bioline alcanzó un 98.1% de sensibilidad** y un **VPN de 99.7%**.
- **Esto significa que en el territorio de Salta, utilizando SD Bioline, menos de 1 de cada 100 personas infectadas recibiría un diagnóstico falso negativo**.
- Ambos reactivos superaron holgadamente el criterio de aceptación mínimo de la OPS **(Sensibilidad >92%, Especificidad >95%)** y los parámetros recomendados en sus guías de diagnóstico clínico **(Sensibilidad ≥94%, Especificidad ≥97%)**

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

TABLE 5 Performance parameters of RDTs in the populations from Salta and Buenos Aires[a]

	SALTA						Buenos Aires					
	RDT SD-Bioline			RDT Wiener			RDT SD-Bioline			RDT Wiener		
	I	NI	T	I	NI	T	I	NI	T	I	NI	T
P	52	7	59	50	2	52	51	3	54	49	2	54
N	1	359	360	3	364	367	2	70	72	4	71	72
T	53	366	419	53	366	419	53	73	126	53	73	126

	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI
Sensitivity	98.1	93.5-100	94.3	87.2-100	96.2	90.2-100	92.5	84.4-100
Specificity	98.1	96.6-99.6	99.6	98.6-100	95.9	90.7-100	97.3	92.8-100
PPV	88.1	79.0-97.2	96.6	90.0-100	99.4	87.4-100	96.1	89.8-100
NPV	99.7	99.0-100	99.2	98.1-100	97.2	92.7-100	94.7	88.9-100
PLR	51.3	24.6-106.9	172.6	43.3-688.8	23,42	7.7-71.0	33.7	8.6-132.7
NLR	0.02	0.0-0.13	0.06	0.02-0.17	0.04	0.0-0.02	0.08	0.03-0.20
Youden Index	0.96	0.92-1.00	0.94	0.88-1.00	0.92	0.85-0.99	0.90	0.82-0.98
Kappa Index	0.918	0.861-0.974	0.946	0.898-0.993	0.919	0.849-0.988	0.902	0.825-0.978

[a]P, positive; N, negative; T, total; I, infected; NI, not infected; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; PLR, positive likelihood ratio; NLR, negative likelihood ratio.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Conclusiones

- Ambas pruebas (SD Bioline y Wiener Lab) mostraron un desempeño ligeramente mejor en los pacientes de Salta que en los de Buenos Aires
- El test de **SD Bioline en el grupo de Salta mostró una sensibilidad del 98.1% y un Valor Predictivo Negativo (VPN) del 99.7%** (3 de cada 1000 personas infectadas recibirían un falso negativo en territorio)
- El test de SD Bioline mostró parámetros aceptables en Buenos Aires según las recomendaciones de la OPS
- **Resumen:** la evidencia empírica muestra que las pruebas rápidas son herramientas de tamizaje sumamente eficaces y confiables en zonas de alta endemicidad como Salta, respaldando su implementación directa en el primer nivel de atención

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Impacto en Salud Pública y Conclusiones

Estrategia en estudios poblacionales

Los test rápidos son una herramienta indispensable para alcanzar el tamizaje universal en estudios poblacionales alcanzando ampliar el territorio de estudio incluyendo zonas rurales dispersas

Acceso Universal y Equidad

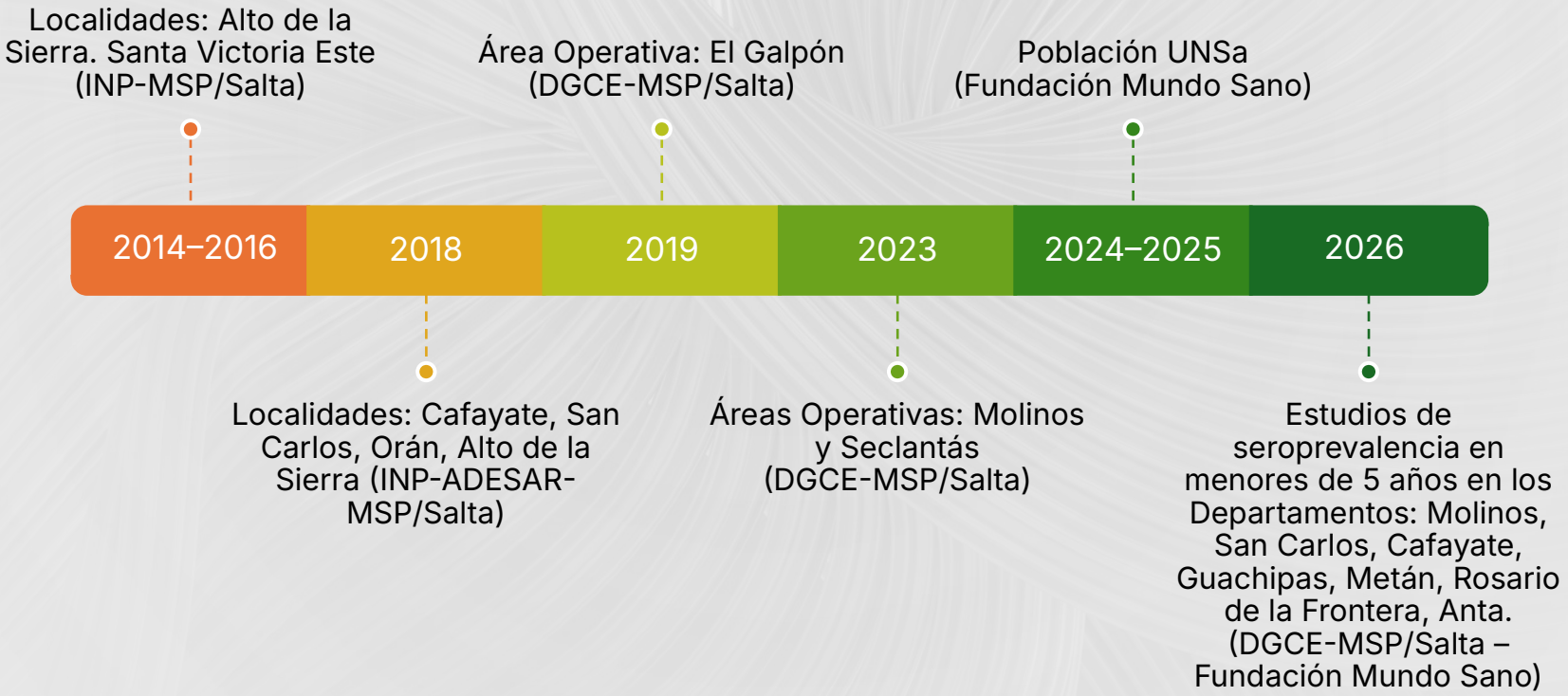
Permiten captar de manera temprana a niños y adultos en el primer nivel de atención, facilitando el inicio del tratamiento antiparasitario y la monitorización clínica antes del desarrollo de cardiopatías u otras complicaciones graves.

Conclusión del estudio

Los resultados del trabajo de campo respaldan enfáticamente la incorporación de estos dispositivos en las estrategias de control de la provincia de Salta, mejorando sustancialmente las barreras de acceso al diagnóstico en poblaciones vulnerables.

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

Experiencias en Salta



© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

DGCE - MSP - SALTA

El Hilo Conductor con la Estrategia ETMI-PLUS

"¿Por qué el éxito de Alto la Sierra en 2017 cambia las reglas del juego para ETMI-PLUS?"

Superación de la barrera de infraestructura

El marco **ETMI-Plus** de la OPS/OMS exige el tamizaje prenatal universal para evitar la transmisión congénita . Sin embargo, en la ruralidad dispersa de Salta, procesar suero convencional requiere centrifugación, refrigeración y transporte, lo que demora el diagnóstico.

Descentralización del tamizaje

Al probar científicamente en Salta que la **sangre entera (punción digital)** tiene una **sensibilidad idéntica (100% en el piloto)** a la del suero de laboratorio, se habilita la posibilidad de realizar el tamizaje de Chagas en el mismo momento de la consulta prenatal de Atención Primaria de la Salud (APS) .

Cero pérdida de oportunidad y Fortalecimiento de SeVICha

En lugar de esperar el retorno de muestras de laboratorios centrales, la mujer embarazada recibe su resultado preliminar en **15-30 minutos** . Esto permite coordinar de forma inmediata el seguimiento del recién nacido mediante técnicas directas o qPCR al momento del nacimiento, reduciendo a cero la pérdida de seguimiento en el binomio madre-hijo .

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com

DGCE - MSP - SALTA

Experiencia en Salta ETMI-Plus

2018 a la fecha

Realización de PDR Chagas en personas gestantes (mas de 3000) del Área Operativa Santa Victoria Este.

Actividad coordinada de la Subsecretaría de Medicina Social /ADESAR-Mundo Sano

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com



Muchas gracias

DGCE - MSP - SALTA

© 2026 Francisco M. García Campos · Licencia CC BY-NC-ND 4.0: citar la fuente, sin uso comercial ni obras derivadas · franciscogarciacampos.com